Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
3ª Vara Cível da Comarca de Passo Fundo

Rua General Neto, 486 - Bairro: Centro - CEP: 99010022 - Fone: (54) 3311-5377 - Balcão virtual: (54) 999426870 - Email: frpasfundo3vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5020620-54.2022.8.21.0021/RS

AUTOR: DAIANI PINHEIRO DA SILVA VIEIRA

RÉU: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS

SENTENÇA

Vistos.

DAIANI PINHEIRO DA SILVA VIEIRA ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fornecimento de Medicamento em desfavor de **UNIMED NACIONAL**, ambos qualificados nos autos, aduzindo que é beneficiária do plano de saúde ofertado pela ré na modalidade plano coletivo por adesão, possuindo diagnóstico de esteatose hepática, diabete mellitus pré-existente, obesidade e convulsões. Afirmou que, diante da gravidade do quadro clínico, a médica hepatologista prescreveu como necessário o tratamento com o uso do medicamento denominado "Semaglutida (ozempic)". Disse ter solicitado à requerida o fornecimento da medicação, negada sob o argumento de que não faz parte do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Defendeu a incidência do CDC ao caso concreto. Postulou, em sede de tutela de urgência, a determinação para que a ré forneça o medicamento em questão. Discorreu acerca da excepcionalidade da taxatividade do rol da ANS, diante da comprovada eficácia do tratamento, à luz da medicina. Ao final, requereu a procedência da ação, tornando definitivo os efeitos da medida postulada. Pediu a concessão da gratuidade judiciária e juntou documentos (evento 1, INIC1).

Deferida a gratuidade judiciária e indeferida a tutela de urgência postulada (evento 3, DESPADEC1).

Irresignada, a demandante interpôs agravo de instrumento (evento 8), sobrevindo decisão de não provimento (evento 19).

A terceira Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das Cooperativas Médicas compareceu espontaneamente no feito (evento 10, PET1). Sustentou que a prestação do medicamento requerido não foi contratado pela autora, aduzindo que o seu uso é considerado tratamento clínico experimental. Referiu que o serviço em questão não está presente no rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS, considerado taxativo pelo Superior Tribunal de Justiça. Falou sobre a necessidade de razoabilidade na aplicação do CDC ao caso concreto. Pugnou pela improcedência da ação e juntou documentos.

Citada (evento 7, AR1), a ré apresentou contestação (evento 13, CONT1). Preliminarmente, acusou a ilegitimidade passiva, apontado como legitimada a Unimed Estado de São Paulo - Federação Estadual das Cooperativas Médicas. Ao final, pugnou pelo acolhimento da preliminar e, consequentemente, a retificação do polo passivo. Juntou documentos.

Houve réplica (evento 17, RÉPLICA1), tendo a autora manifestado concordância com a retificação do polo passivo (evento 16, PET1).

Extinto o feito em relação à requerida Unimed Central, com o recebimento da substituição do polo passivo requerido pela autora e intimação das partes acerca do interesse na dilação probatória (evento 30, DESPADEC1), ambas pediram pelo julgamento antecipado do feito (evento 35, PET1 e evento 37, PET1).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório. Decido.

Cabível o julgamento do feito no estado em que se encontra, com fundamento no art. 355, inciso I, do CPC.

Inexistindo preliminares a serem analisadas, passo diretamente ao exame do mérito.

Trata-se de ação de obrigação de fazer em que pretende a autora ver a ré compelida a fornecer o medicamento Ozempic (semaglutida) 1 mg, de uso contínuo e aplicação subcutânea.

Cumpre referir que a relação posta nos autos é tipicamente de consumo, do que decorre a incidência das regras previstas pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 608 do STJ:

"*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.*".

A condição da autora de beneficiária do plano de saúde gerido pela demandada, restou demonstrada por meio do documento anexo ao evento 1, OUT7.

De acordo com o receituário lavrado pela médica assistente (evento 1, RECEIT11), a demandante necessita do uso da medicação com o objetivo de redução de peso e perda da gordura visceral, medidas necessárias para o êxito no tratamento do acometimento por obesidade (grau 1), associada à esteotose (grau 3) e fibrose hepática.

Por sua vez, a solicitação administrativa de cobertura do medicamento foi encaminhada via e-mail à ré pela autora (evento 1, OUT8), oportunidade em que recebida resposta contendo a negativa do pedido, justificada pela não cobertura pelo rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, sendo este o mesmo argumento apresentado na oportunidade da contestação.

De: autoriza@unimedpf.com.br <autoriza@unimedpf.com.br>
Enviado: quinta-feira, 21 de julho de 2022 07:31
Para: pinheirodai <pinheirodai@hotmail.com>
Assunto: Re: Requerimento de medicamentos - Senha 7603131

Bom dia Daiani.

Infelizmente é o contato que tenho com eles. Tenho via chat, mas é apenas para verificar a situação da solicitação.
Segue a baixo a resposta da Unimed responsável ao seu contrato.
Unimed São Paulo - Desfavorável - sem cobertura pelo Rol de procedimentos e eventos em saude da ANS.

Att.

Unimed Planalto Médio/RS
Rodrigo Moura de Lima
Autorizações
(54) 3317 6370 / 6371 / 6372
www.unimed.coop.br/planaltomedio

Nesse viés, sendo a autora beneficiária de plano de saúde regulamentado pela Lei nº 9.656/98, devem ser observadas, prioritariamente, as coberturas definidas na Resolução Normativa nº 465/01 da ANS, que apresenta Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde:

> *Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, **exceto**: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)*
>
> *[...]*
>
> *VI - **fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;** (Redação dada pela Lei nº 12.880, de 2013) (Vigência)*
>
> *[...]*
>
> *§ 1º **As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS.** (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)*
>
> *[...]*
>
> *§ 4º **A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS.** (Vide Medida Provisória nº 1.665, de 1998)(Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) (grifei)*

Além disso, em 21/09/2022 sobreveio a Lei nº 14.454/2022, a qual, alterando o art. 10º da Lei nº 9.656/98, expressamente estabeleceu que:

> *§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:*
>
> ***I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou***
>
> ***II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.***

No caso dos autos, em que pese a relevância do diagnóstico e da recomendação médica, entendo que a parte autora não logrou comprovar a existência de situação excepcional, apta a justificar a mitigação da exclusão legal para cobertura do tratamento.

Ademais, não se trata de situação de emergência, considerando que o diagnóstico médico de obesidade, associada à doenças agravadas por esta condição, apenas refere o uso da medicação para atender a necessidade de perda de peso, sem, todavia, atestar a urgência ou emergência na providência.

Outrossim, diante do diagnóstico apresentado, convém mencionar a existência de nota técnica, emitida pelo Sistema Nacional de Pareceres e Notas Técnicas, ferramenta que almeja fornecer aos magistrados brasileiros fundamentos científicos para julgar ações que envolvam o direito à saúde.

Na análise do caso, houve manifestação desfavorável à cobertura do medicamento, constatando-se, inclusive, a existência de outros medicamentos indicados para o tratamento da obesidade aprovados no Brasil, além de estratégias não medicamentosas para esse diagnóstico. Senão, vejamos:

> *"**1. NÃO É FAVORÁVEL** ao fornecimento do medicamento **OZEMPIC (SEMAGLUTIDA),** por considerar que seu uso para tratamento da obesidade não possui autorização no Brasil, sendo, portanto, off label. Há outros medicamentos com essa indicação aprovados no Brasil e estratégias não medicamentosas para esse diagnóstico. [...]*[1]*"*

Nesse sentido, filiou-se a jurisprudência do Eg. TJ/RS:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. **PRÉ-DIABETES E OBESIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO *OZEMPIC*. AMBIENTE DOMICILIAR. COBERTURA NÃO DEVIDA.** 1. A INAPLICABILIDADE DO CDC AOS PLANOS DE SAÚDE NA MODALIDADE

DE AUTOGESTÃO NÃO IMPLICA INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO (ARTS. 421 E 422 DO CC). O ART. 423 DO CC DETERMINA QUE, NO CONTRATO DE ADESÃO, DEVE-SE ADOTAR A INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ADERENTE. 2. NA ESTEIRA DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STJ, NÃO SE AFIGURA ILÍCITA A EXCLUSÃO DE COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR, SALVO OS ANTINEOPLÁSICOS ORAIS (E CORRELACIONADOS), A MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) E OS INCLUÍDOS NO ROL DA *ANS* PARA ESSE FIM. **3. HIPÓTESE EM QUE A PARTE AUTORA NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA EXCLUSÃO CONTRATUAL E LEGAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.** SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. 5. NOTA TÉCNICA 107553 PRODUZIDA PELO NATJUS COM CONCLUSÃO DESFAVORÁVEL À UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50125358920218210029, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-03-2023) - grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO *OZEMPIC*.** AUSÊNCIA DO DEVER DE COBERTURA. SENTENÇA REFORMADA. - No que tange aos medicamentos de uso domiciliar, o STJ tem entendimento de que "é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais e correlacionados, a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da *ANS* para esse fim". - **Caso em que não é devido o custeio do medicamento almejado, pois, além de ser de uso domiciliar, não está presente no rol de cobertura obrigatória da *ANS*, nem objeto de contratação específica junto à ré.** APELO PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50112799820228210022, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 03-06-2024) - grifei.

Portanto, tenho que a parte não logrou êxito em demonstrar os requisitos legais que determinam a possibilidade de cobertura, notadamente aqueles descritos nas hipóteses excepcionais do art. 10, § 13, inciso I, da Lei nº 9.656/98, tornando impositivo o desacolhimento da pretensão inicial.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, **JULGO IMPROCEDENTE** a pretensão formulada por **DAIANI PINHEIRO DA SILVA VIEIRA** em desfavor de **UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS**, nos termos da fundamentação.

Sucumbente, condeno a demandante ao pagamento das custas processuais e honorários ao procurador da parte adversa, os quais fixo em R$ 1.000,00, tendo em vista a natureza da ação, tempo de tramitação processual e trabalho exigido daquele profissional, observadas as diretrizes do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, quantia a ser corrigida monetariamente pelo IPCA (§ único do art. 389 do CC), a contar da presente decisão.

Suspendo a exigibilidade dos ônus sucumbenciais em relação à autora, pois litiga sob o abrigo da gratuidade judiciária (evento 3, DESPADEC1).

Intimem-se.

Considerando que o Código de Processo Civil de 2015 suprimiu o juízo de admissibilidade dos recursos realizado pelo primeiro grau, sem necessidade de nova conclusão, exceto na hipótese de embargos de declaração, em sendo interposta apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, querendo, no prazo de 15 dias (§ 1º do art. 1.010 do CPC).

Na hipótese de sobrevir apelação adesiva no mesmo lapso, intime-se o recorrido adesivo para apresentar contrarrazões em 15 dias (§ 2º do art. 1.010 do CPC).

Cumpridas as diligências legais, encaminhem-se ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido e tomadas eventuais providências quanto às custas, baixem-se e arquivem-se os autos.

Documento assinado eletronicamente por **JULIANA PASETTI BORGES, Juíza de Direito**, em 4/11/2024, às 15:29:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10071024914v44** e o código CRC **184c966a**.

---

1. https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?idNotaTecnica=107553 ↩